Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 3 · Oktober 2026
S. 72–75 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

PRAXIS UND LEHRE

KI-Werkzeuge im klinischen Alltag

Dokumentation, Psychoedukation und Unterstützung zwischen den Sitzungen unter den Bedingungen von Einwilligung, Datenschutz und beruflicher Verantwortung

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe und Sora Pazer
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Generative künstliche Intelligenz (KI) ist aus den Forschungslaboren in den Arbeitsalltag von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Beraterinnen und Beratern gelangt, häufig schneller, als sich fachliche Leitlinien entwickelt haben. Dieser Praxisbeitrag untersucht drei Bereiche, in denen KI-Werkzeuge in der alltäglichen klinischen Arbeit eingesetzt oder vorgeschlagen werden: die klinische Dokumentation, die Erstellung psychoedukativer Materialien und die Unterstützung von Patientinnen und Patienten zwischen den Sitzungen. Für jeden Bereich skizzieren wir plausible Vorteile, etwa eine geringere administrative Belastung und passgenauere Informationen, und beschreiben charakteristische Risiken, darunter erfundene Inhalte, Verzerrungen klinischer Bedeutung und die Weitergabe sensibler Daten an externe Anbieter. Anschließend erörtern wir den normativen Rahmen, in dem solche Werkzeuge eingesetzt werden müssen: eine spezifische und widerrufliche informierte Einwilligung, die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an Gesundheitsdaten, die neuen Pflichten aus der KI-Verordnung der EU sowie die fortbestehende berufliche Verantwortung der Behandelnden für jedes Dokument und jede Intervention. Gestützt auf Befunde zu digitalen Angeboten für die psychische Gesundheit und auf ethische Analysen von KI in der Psychotherapie formulieren wir praktische Empfehlungen für Behandelnde und Einrichtungen. Aus sinnzentrierter Perspektive argumentieren wir, dass KI Behandelnde von Aufgaben entlasten kann, nicht aber von Verantwortung, die den Kern professioneller Praxis bildet.

Schlüsselwörter: künstliche Intelligenz · klinische Dokumentation · Unterstützung zwischen den Sitzungen · informierte Einwilligung · Datenschutz

ABSTRACT

Generative artificial intelligence (AI) has moved from research laboratories into the daily routines of psychotherapists and counselors, often faster than professional guidance has developed. This practice paper examines three areas in which AI tools are used or proposed in everyday clinical work: clinical documentation, the preparation of psychoeducational material, and support for patients between sessions. For each area, we outline plausible benefits, such as reduced administrative burden and more tailored information, and describe characteristic risks, including fabricated content, distortions of clinical meaning, and the transfer of sensitive data to external providers. We then discuss the normative framework within which such tools must be used: informed consent that is specific and revocable, the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR) for health data, the emerging obligations of the EU AI Act, and the enduring professional responsibility of the clinician for every document and intervention. Drawing on evidence from digital mental health and on ethical analyses of AI in psychotherapy, we formulate practical recommendations for clinicians and institutions. From a meaning-centered perspective, we argue that AI can relieve clinicians of tasks but not of responsibility, which remains at the core of professional practice.

Keywords: artificial intelligence · clinical documentation · between-session support · informed consent · data protection

1 Einleitung

Innerhalb weniger Jahre sind große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) für alle zugänglich geworden, die über einen Browser verfügen. Behandelnde begegnen ihnen inzwischen als konkrete Angebote: Software, die Sitzungsnotizen entwirft, Assistenzsysteme, die Berichte zusammenfassen, und Chatbots, die Patientinnen und Patienten aus eigener

Initiative nutzen. Frühere Übersichtsarbeiten zur digitalen Psychiatrie beschrieben ein Feld aus Apps, internetbasierten Programmen und frühen Dialogsystemen, deren Evidenzbasis uneinheitlich war und deren Implementierung hinter der technischen Entwicklung zurückblieb (Torous et al., 2021). Generative KI verschärft diese Lücke: Die Werkzeuge sind leistungsfähiger und weiter verbreitet, doch fachliche Leitlinien, institutionelle Regelungen und empirisches Wissen über ihren Einsatz in der Regelversorgung bleiben begrenzt (Stade et al., 2024).

Dieser Praxisbeitrag richtet sich an Behandelnde, die den Einsatz von KI-Werkzeugen in ihrer alltäglichen Arbeit erwägen oder sie bereits nutzen. Er bewertet keine einzelnen kommerziellen Produkte, deren Funktionen sich rasch ändern, sondern beschreibt typische Anwendungsfälle und die Fragen, die sie aufwerfen. Wir konzentrieren uns auf Dokumentation, Psychoedukation und Unterstützung zwischen den Sitzungen und wenden uns anschließend der informierten Einwilligung, dem Datenschutz und der beruflichen Verantwortung zu. Ziel ist es weder, den Einsatz von KI zu fördern, noch, von ihm abzuraten, sondern eine überlegte, transparente und verantwortbare Praxis zu unterstützen.

2 Dokumentation und administrative Unterstützung

Die Dokumentation ist ein naheliegender Einstiegspunkt, weil sie zeitaufwendig, teilweise standardisiert und oft als fern von der eigentlichen therapeutischen Arbeit erlebt wird. LLM-basierte Werkzeuge können Stichworte in lesbare Notizen überführen, Berichte für Kostenträger oder überweisende Ärztinnen und Ärzte strukturieren oder frühere Unterlagen zusammenfassen. Manche Produkte zeichnen zusätzlich Sitzungen auf und erzeugen Notizen aus Transkripten. Befürworterinnen und Befürworter erwarten Zeitersparnis und eine geringere administrative Belastung, auch wenn belastbare Evidenz für solche Effekte in der Psychotherapie noch rar ist (Stade et al., 2024).

Die Risiken sind technologiespezifisch. Sprachmodelle erzeugen flüssige Texte auf der Grundlage statistischer Muster und können Aussagen hervorbringen, die plausibel, aber durch die Eingabe nicht gedeckt sind, ein Phänomen, das als Halluzination bezeichnet wird (Ji et al., 2023). In einer klinischen Akte ist ein erfundenes Symptom, eine falsch zugeordnete Äußerung oder eine geglättete Ambivalenz kein stilistischer Mangel, sondern ein Dokumentationsfehler mit möglichen Folgen für Diagnostik, Behandlung und rechtliche Verfahren. Zudem können Modelle, die auf großen Textkorpora trainiert wurden, in ihren Trainingsdaten enthaltene Stereotype reproduzieren (Bender et al., 2021), was sich darin niederschlagen kann, wie Verhalten, Kultur oder Identität einer Patientin oder eines Patienten beschrieben werden.

Ein weiteres Problem ist weniger sichtbar. Das Verfassen von Notizen ist nicht nur ein administrativer Akt, sondern auch ein Moment der Reflexion, in dem Behandelnde ihre Eindrücke ordnen und Hypothesen formulieren. Wird das Entwerfen vollständig delegiert, kann diese reflexive Funktion geschwächt werden. Eine vorsichtige Praxis nutzt KI daher zur Formatierung und sprachlichen Überarbeitung von Inhalten, die die Behandelnden bereits selbst formuliert haben, statt zur Erzeugung klinischer Einschätzungen, und behandelt jeden Entwurf als Vorschlag, der Zeile für Zeile zu prüfen ist.

3 Psychoedukation und Unterstützung zwischen den Sitzungen

Psychoedukation eignet sich für KI-Unterstützung, weil sie zu großen Teilen darin besteht, gut etablierte Konzepte in verständlicher Sprache zu erklären. Behandelnde können LLMs nutzen, um Informationsblätter zur Schlafhygiene, zum Vermeidungskreislauf bei Angst oder zum Rational der Verhaltensaktivierung zu entwerfen und sie an das Leseniveau oder die bevorzugte Sprache einer Patientin oder eines Patienten anzupassen. Solche Entwürfe können Zeit sparen, erfordern aber eine sorgfältige Prüfung, da generierte Erklärungen veraltet, übervereinfacht oder auf subtile Weise ungenau sein können (Ji et al., 2023). Die Behandelnden bleiben für schriftliches Material, das sie Patientinnen und Patienten aushändigen, ebenso verantwortlich wie für alles, was in der Sitzung gesagt wird.

Die Arbeit zwischen den Sitzungen ist ein zentraler Bestandteil vieler Behandlungen, und metaanalytische Befunde legen nahe, dass Hausaufgaben in kognitiven und behavioralen Therapien mit besseren Ergebnissen einhergehen (Kazantzis et al., 2010). Internetbasierte Behandlungen mit unterschiedlich ausgeprägter therapeutischer Begleitung haben eine beträchtliche Evidenzbasis aufgebaut (Andersson et al., 2019). Dialogsysteme stellen eine neuere Form dar: Eine frühe Studie zu einem regelbasierten Chatbot berichtete kurzfristige Reduktionen depressiver Symptome (Fitzpatrick et al., 2017), und eine erste randomisierte Studie zu einem generativen KI-

Chatbot berichtete Symptomverbesserungen im Vergleich zu einer Wartelistenbedingung (Heinz et al., 2025). Diese Befunde sind ermutigend, aber begrenzt durch kurze Nachbeobachtungszeiträume, selektierte Stichproben und Vergleichsbedingungen, die keine Schlüsse über einen Zusatznutzen gegenüber etablierten Interventionen erlauben.

Für die klinische Praxis ist entscheidend, ob ein Werkzeug in die Behandlung eingebunden ist oder von Patientinnen und Patienten eigenständig genutzt wird. Wenn Behandelnde eine KI-basierte Anwendung empfehlen, sollten sie deren Zweckbestimmung, deren Umgang mit Krisensituationen und deren Datenpraxis kennen. Eine frühe Studie zeigte, dass verbreitete Smartphone-Assistenten auf Äußerungen zu Suizidgedanken, Depression und Gewalt uneinheitlich und oft unangemessen reagierten (Miner et al., 2016). Heutige Systeme unterscheiden sich erheblich, doch der Umgang mit Krisen muss weiterhin geprüft statt vorausgesetzt werden. Ebenso wichtig ist es, Patientinnen und Patienten offen zu fragen, ob sie bereits allgemeine Chatbots zur emotionalen Unterstützung nutzen, da eine solche Nutzung häufig nicht von sich aus angesprochen wird.

4 Informierte Einwilligung und Datenschutz

Jeder Einsatz von KI, der Patienteninformationen betrifft, bedarf einer klaren rechtlichen und ethischen Grundlage. Nach der DSGVO gehören Gesundheitsdaten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, deren Verarbeitung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist (European Parliament & Council of the European Union, 2016). Identifizierbare Sitzungsinhalte in einen öffentlich zugänglichen Chatbot einzugeben, bedeutet in der Regel, Gesundheitsdaten an Dritte zu übermitteln, oft außerhalb der Europäischen Union, ohne ausreichende Rechtsgrundlage oder Auftragsverarbeitungsvertrag. Selbst scheinbar anonymisierte Notizen können in Verbindung mit Kontextdetails eine Re-Identifizierung ermöglichen.

Die informierte Einwilligung sollte in diesem Zusammenhang spezifisch statt pauschal sein. Patientinnen und Patienten sollten erfahren, welches Werkzeug zu welchem Zweck eingesetzt wird, welche Daten wo verarbeitet werden, ob Daten zum Training von Modellen verwendet werden und dass eine Ablehnung keine Folgen für ihre Behandlung hat. Die Einwilligung sollte dokumentiert und widerruflich sein. Ethische Analysen von KI in der Psychotherapie haben Transparenz gegenüber Patientinnen und Patienten, Aufmerksamkeit für vulnerable Gruppen und Klarheit über die Grenzen der Technologie betont (Fiske et al., 2019). Die KI-Verordnung der EU ergänzt Transparenzpflichten, etwa dass Menschen informiert werden müssen, wenn sie mit einem KI-System interagieren, und stellt strengere Anforderungen an Systeme, die als hochriskant eingestuft werden (European Parliament & Council of the European Union, 2024). Behandelnde müssen keine Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten werden, sollten aber wissen, ob ihre Werkzeuge und Einrichtungen diese Anforderungen erfüllen.

5 Berufliche Verantwortung und klinisches Urteil

Berufsethische Kodizes verlieren ihre Gültigkeit nicht dadurch, dass eine Aufgabe durch Software unterstützt wird. Pflichten zu Kompetenz, Vertraulichkeit und Schadensvermeidung gelten für jedes unterzeichnete Dokument und jede ausgesprochene Empfehlung (American Psychological Association, 2017). Luxton (2014) sah voraus, dass KI Fragen der Kompetenz und Rechenschaftspflicht in der psychologischen Praxis aufwerfen würde, einschließlich der Notwendigkeit, dass Behandelnde die Möglichkeiten und Grenzen der von ihnen genutzten Systeme verstehen. Bei generativer KI, deren Ausgaben je nach Formulierung, Modellversion und Kontext variieren, wird diese Anforderung dringlich.

Ein spezifisches Risiko ist der Automatisierungsbias, die Neigung, maschinell erzeugte Vorschläge weniger kritisch zu prüfen als die eigenen Überlegungen. Ein gut formulierter Entwurf kann überzeugender wirken, als er es verdient. Die Logotherapie beschreibt Verantwortlichsein als Wesensmerkmal menschlicher Existenz: Der Mensch ist es, der auf die Anforderungen einer konkreten Situation zu antworten hat (Frankl, 1946/1985). Auf die berufliche Praxis übertragen, legt dies ein einfaches Prinzip nahe: KI kann Aufgaben übernehmen, aber keine Verantwortung. Wer einen Satz in einen Bericht übernimmt, steht für ihn ein, als wäre es der eigene.

6 Praktische Empfehlungen

Für die individuelle Praxis ergeben sich mehrere Empfehlungen. Erstens sollten keine identifizierbaren Patientendaten in Werkzeuge eingegeben werden, für die kein DSGVO-konformer Auftragsverarbeitungsvertrag und keine transparenten Informationen über den Speicherort und die Verwendung von Daten zu Trainingszwecken vorliegen. Zweitens sollten KI-generierte Entwürfe

von Notizen, Berichten und Informationsmaterialien vor der Verwendung vollständig geprüft und korrigiert werden; Diagnosen und Risikoeinschätzungen sollten von den Behandelnden selbst formuliert werden. Drittens sollten Patientinnen und Patienten in verständlicher Sprache informiert und um ausdrückliche Einwilligung gebeten werden, wann immer ihre Daten durch KI-Werkzeuge verarbeitet werden.

Weitere Empfehlungen betreffen die Behandlung und die Einrichtungen. Viertens sollten Anwendungen, die für die Zeit zwischen den Sitzungen empfohlen werden, auf der Grundlage verfügbarer Evidenz, transparenter Krisenprotokolle und ihrer Datenpraxis ausgewählt werden, und ihre Nutzung sollte in den Sitzungen besprochen werden. Fünftens sollten Behandelnde routinemäßig nach der eigenständigen Chatbot-Nutzung ihrer Patientinnen und Patienten fragen und deren Bedeutung erkunden, ohne sie abzuwerten. Sechstens sollten Einrichtungen schriftliche Regelungen verabschieden, die zugelassene Werkzeuge, erlaubte Zwecke und Zuständigkeiten festlegen, und Schulungen anbieten. Die Forschung zu digitalen Angeboten für die psychische Gesundheit hat gezeigt, dass die Implementierung nicht nur von der Technologie abhängt, sondern auch von organisatorischen Bedingungen und der Passung zu klinischen Arbeitsabläufen (Mohr et al., 2017); KI-Werkzeuge dürften hier keine Ausnahme bilden.

7 Fazit

KI-Werkzeuge können die administrative Belastung verringern, die Erstellung psychoedukativer Materialien unterstützen und die therapeutische Arbeit in die Zeit zwischen den Sitzungen hinein verlängern. Diese Potenziale sind real, gehen aber mit Risiken erfundener Inhalte, missbräuchlicher Datenverwendung und einer Erosion professioneller Reflexion einher. Die entscheidende Frage für den klinischen Alltag lautet daher nicht, ob KI eingesetzt wird, sondern wie: transparent, mit informierter Einwilligung, im Einklang mit dem Datenschutzrecht und unter der vollen Verantwortung der Behandelnden. So eingesetzt, kann KI Behandelnde von Aufgaben entlasten und mehr Raum für das lassen, was ihre eigentliche Arbeit bleibt: die Begegnung mit einem Menschen auf der Suche nach Sinn.

Literatur

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct (2002, amended effective June 1, 2010, and January 1, 2017). https://www.apa.org/ethics/code

Andersson, G., Titov, N., Dear, B. F., Rozental, A., & Carlbring, P. (2019). Internet-delivered psychological treatments: From innovation to implementation. World Psychiatry, 18(1), 20–28. https://doi.org/10.1002/wps.20610

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

European Parliament & Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 1–88.

European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, L, 2024/1689.

Fiske, A., Henningsen, P., & Buyx, A. (2019). Your robot therapist will see you now: Ethical implications of embodied artificial intelligence in psychiatry, psychology, and psychotherapy. Journal of Medical Internet Research, 21(5), e13216. https://doi.org/10.2196/13216

Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. JMIR Mental Health, 4(2), e19. https://doi.org/10.2196/mental.7785

Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning (Rev. ed.). Washington Square Press. (Original work published 1946)

Heinz, M. V., Mackin, D. M., Trudeau, B. M., Bhattacharya, S., Wang, Y., Banta, H. A., Jewett, A. D., Salzhauer, A. J., Griffin, T. Z., & Jacobson, N. C. (2025). Randomized trial of a generative AI chatbot for mental health treatment. NEJM AI, 2(4). https://doi.org/10.1056/AIoa2400802

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Kazantzis, N., Whittington, C., & Dattilio, F. (2010). Meta-analysis of homework effects in cognitive and behavioral therapy: A replication and extension. Clinical Psychology: Science and Practice, 17(2), 144–156. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2010.01204.x

Luxton, D. D. (2014). Artificial intelligence in psychological practice: Current and future applications and implications. Professional Psychology: Research and Practice, 45(5), 332–339. https://doi.org/10.1037/a0034559

Miner, A. S., Milstein, A., Schueller, S., Hegde, R., Mangurian, C., & Linos, E. (2016). Smartphone-based conversational agents and responses to questions about mental health, interpersonal violence, and physical health. JAMA Internal Medicine, 176(5), 619–625. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.0400

Mohr, D. C., Weingardt, K. R., Reddy, M., & Schueller, S. M. (2017). Three problems with current digital mental health research . . . and three things we can do about them. Psychiatric Services, 68(5), 427–429. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201600541

Stade, E. C., Stirman, S. W., Ungar, L. H., Boland, C. L., Schwartz, H. A., Yaden, D. B., Sedoc, J., DeRubeis, R. J., Willer, R., & Eichstaedt, J. C. (2024). Large language models could change the future of behavioral healthcare: A proposal for responsible development and evaluation. npj Mental Health Research, 3, Article 12. https://doi.org/10.1038/s44184-024-00056-z

Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt-Jepsen, M., Whelan, P., Carvalho, A. F., Keshavan, M., Linardon, J., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: Current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality. World Psychiatry, 20(3), 318–335. https://doi.org/10.1002/wps.20883

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). AI Tools in Everyday Clinical Practice: Documentation, psychoeducation, and between-session support under the conditions of consent, data protection, and professional responsibility. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(3), 72–75.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.